

49 - 02-Les ascites - Pr K. KRATI

L'acide est un signe clinique qui peut accompagner plusieurs pathologies qui peuvent être digestives ou extra digestives, d'où l'intérêt de sa connaissance. Le médecin doit être capable donc de reconnaître cliniquement un acide, quelle que soit son abondance. Il doit être aussi capable de préciser les facteurs de cet acide, d'identifier les acides qui sont riches en protides ou pauvres en protides au chilaire, parce qu'en fonction de l'aspect de liquide d'acide, la cause peut être différente.

Et surtout, le médecin doit être capable de mener une enquête étiologique bien codifiée ou devant la découverte d'un acide. Il doit connaître les principales étiologies des acides riches en protides et aussi des acides pauvres en protides. C'est quoi un acide ? Tout simplement, c'est la présence d'un épanchement liquidien non pérulant et non hémorragique dans la cavité péritoniale.

Il représente une expression clinique de pathologies barrières nombreuses. Pour arriver au diagnostic étiologique, il est très important de mener une enquête étiologique qui est basée essentiellement sur la clinique, sur l'échographie et la nature de liquide d'acide, après donc fonction d'acide. Pour appel physiologique, le péricote est formé par deux feuilles, un feuille paritale et un feuille viscérale.

Le feuille paritale est contre le parois et le feuille viscérale recouvre les organes intra-abdominaux. Ce péricote est une surface d'échanges qui permet qu'il y ait un effluide d'environ 200 millilitres à partir d'un ultrafiltrat du plasma. Ce liquide à l'intérieur du péricote permet le glissement des deux feuilles l'une contre l'autre, ce qui permet aux organes intra-abdominaux de bouger un petit peu lors de la respiration et lors des changements de mouvements de l'individu sans qu'il y ait des frottements.

Le liquide intra-péritoneal existe en une quantité bien définie, c'est un liquide qui est donc riche en certains immunoglobulins qui permettent d'avoir des propriétés anti-infectieuses et donc d'éviter, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'infection au niveau de ce liquide. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a un équilibre entre le liquide qui rentre et le liquide qui sort. Et donc, s'il y a un déséquilibre entre la production, donc l'entrée de liquide à l'intérieur de la cavité péritoneale et le drainage de celui-ci, en cas de déséquilibre on va avoir là une acide.

Et sur le plan physiopathologique, il y a des acides dites mécaniques où l'épanchement péritoneal est tout simplement la conséquence des phénomènes mécaniques, soit une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires venus splanchniques, consécutive le plus souvent hypertension portale, soit il y a une diminution de la pression oncrotique du fait de l'hypoalbumine, soit il y a des phénomènes inflammatoires avec une atteinte péritoneale qui peut être soit infectieuse, soit myoplasique, soit inflammatoire, qui serait à l'origine d'un liquide qui sera riche en albumine. Le diagnostic positif. En fait, les circonstances découvertes sont

variables.

L'acide peut être découvert de façon fortuite chez un patient qui peut être asymptomatique ou qui vient consulter pour une symptomatologie non liée à l'acide en elle-même. Et c'est l'examen clinique qui va mettre en évidence l'acide ou une échographie qui va être réalisée, qui va mettre en évidence une acide. Soit le malade vient pour une symptomatologie liée à l'acide, notamment une sensibilité abdominale ou une douleur abdominale ou une gêne.

Cet acide est responsable d'une gêne respiratoire ou des vomissements d'une gêne de l'alimentation ou une distension abdominale. Soit que le malade vient consulter pour une altération de l'état général. Donc, quel que soit le motif qui va amener le malade à consulter, là c'est l'examen clinique qui permet de faire le diagnostic de l'acide.

Et le tableau clinique, il est variable en fonction de l'abondance de l'acide. Est-ce qu'il s'agit d'un acide de grande, de moyenne ou de faible abondance, mais aussi du caractère libre ou non de l'acide. Et là, nous commençons par décrire les données cliniques d'un acide de moyenne abondance libre dans la cavité péritoniale.

Cet acide peut être suspecté déjà à l'inspection devant une augmentation de volume de l'abdomen, en particulier lorsque le malade est en position debout de profil et on note cette dilatation au-dessus de l'ombilique avec parfois même une hernie ombilicale. La palpation peut aussi faire suspecter un acide lorsqu'il est difficile de déprimer la paroi et lorsque l'on n'arrive pas à palper de façon aisée le foie et la rate à travers cet épanchement péritonien. Attention, parfois lorsqu'on a une hépatoscopie ombilicale avec un acide, lorsqu'on palpe au niveau de l'abdomen, on va créer une pression sur l'hépatomégalie ou l'asthmomégalie qui va descendre et peut remonter, buter contre la main de l'examineur et ça donne ce qu'on appelle le signe de glaçon.

Ce signe de glaçon qui témoigne de la présence de l'acide et aussi de l'hépatomégalie ou d'une masse intra-abdominale. Ça aussi c'est un signe qui est important à rechercher par la palpation. Mais le diagnostic de l'acide de moyenne abondance libre repose essentiellement sur la percussion car celle-ci va rechercher une maturité déclinée mobile.

Pourquoi une maturité déclinée mobile ? Parce que l'acide, le liquide est dans la cavité péritoniale, il est de moyenne abondance, donc il va se collecter et se rassembler au niveau des ondes déclinées et si le malade change de position, il va aussi toujours aller vers les ondes les moins déclinées. C'est pour ça qu'on va rechercher cet acide chez un patient d'abord en décubitus dorsal et puis en décubitus latéral. On va percuter au niveau de l'abdomen, on va essayer de limiter la maturité.

Lorsqu'on est en décubitus dorsal, ça va donner une maturité avec une limite concave vers le haut qui encadre la sonorité péri-ombilicale. Lorsqu'on va le mettre en décubitus latéral, le liquide va changer, il va aller se collecter dans la zone la plus déclinée et donner donc une maturité dans le flanc inférieur. Là on le voit bien sur ces deux photos, on voit du côté gauche la maturité avec

la limite supérieure péri-ombilicale et du côté droit on voit le malade en position latérale et on voit que le liquide va se collecter vers le flanc, vers la partie la plus déclinée.

Ensuite on a l'acide de grande abondance. L'acide de grande abondance est souvent mal toléré, il est souvent associé à une discipline et le malade peut même avoir parfois des problèmes pour s'alimenter parce qu'il peut présenter des vomissements. Il est responsable d'une maturité dessus de tout l'abdomen.

Donc on n'a pas ce caractère, cette maturité, déclive, etc. C'est tout l'abdomen qui va être décliné. Le diagnostic est facile, c'est un patient maigre parce qu'on aura des membres grânes contrastant avec un abdomen qui est distendu et qui est mat et là le diagnostic ne pose pas de problème.

Par contre si les patients ne sont pas maigres, parfois il y a un problème devant cette maturité du flanc. Est-ce qu'il y a du liquide ? Est-ce que cette maturité est en rapport avec un liquide intrapéritonéal ou est-ce que tout simplement elle est en rapport avec l'obésité de la paroi abdominale ? C'est pour cela qu'on recherche le signe de flot. C'est quoi le signe de flot ? C'est un signe qui va nous permettre surtout de rechercher, est-ce qu'il y a du liquide à l'intérieur ? Et comment on va le rechercher ? Tout simplement en essayant de rechercher s'il y a une transmission des ongles par le liquide.

Comment on va rechercher cette transmission ? Tout simplement, nous avons besoin de deux examinateurs. Un qui va mettre le bord cubital de son avant-bras sur l'ongle du liquide. Pourquoi mettre cet avant-bras ? On va le placer là.

Tout simplement pour limiter la transmission d'éventuelles ongles par la paroi, par la graisse, pour empêcher en cas d'abdomatité liée à cette graisse de transmettre les ongles. Le deuxième examinateur va essayer de mettre une main d'un côté sur l'abdomen et l'autre main de l'autre côté. Il va essayer d'envoyer des ongles, de créer des ongles sur le côté opposé.

Et lorsqu'il va créer ces ongles, ces ongles en absence d'acide ne peuvent pas être transmis vers l'autre côté parce que la transmission graisseuse est limitée par l'avant-bras qui est situé au niveau de l'ongle liquide. Par contre, s'il y a un liquide, il va transmettre les ongles. Et s'il y a une transmission, s'il y a une perception des ongles de l'autre côté, on dit qu'un signe de flot est positif et ce signe de flot positif traduit donc la présence de liquide d'acide.

Deuxième chose, comme dans l'acide de moyenne abondance, la palpation du foie et de la rate est difficile à travers l'épanchement, mais lorsqu'on a une masse abdominale, lorsqu'on a une hépatosplénomégalie ou une splénomégalie, on aura un signe de glaçon positif, c'est-à-dire que lorsqu'on va entraîner avec un geste, une palpation, une dépression brutale au niveau de l'abdomen va s'accompagner du refoulement de l'organe qui va remonter dans le liquide et donner un choc en retour au niveau des doigts de l'examineur. On dit qu'il y a un signe de

glaçon positif qui traduit au niveau de l'hippocampe de droite l'hépatospléomégalie, au niveau de l'hippocampe de gauche l'aspléomégalie ou une masse, n'importe où sur l'abdomen, une masse intra-abdominale. Là c'est tout simplement un schéma d'un acide de grande abondance.

L'acide libre d'abondance mini, en fait, il est difficile à mettre en évidence parce que la quantité de liquide est inférieure à 2 litres et est responsable d'une discrète flamme d'acide. Où l'examen clinique parfois est difficile à la mettre en évidence, c'est l'échographie en général qui permet de poser le diagnostic et de confirmer l'existence de l'acide. Lorsque l'acide est cloisonné ou enkysté, à ce moment-là, on n'a pas ce caractère mobile de liquide, on n'a pas cette matité qui va être homogène et donc on va avoir plutôt des matités qui sont fixes, localisées et qui peuvent alterner avec des ondes de sonorité.

C'est pour ça que parfois on parle de matités ondamées. C'est grâce à l'échographie qu'on peut confirmer la présence de cet acide cloisonné et aussi là, lorsqu'on veut faire une ponction, on peut la faire de façon écologique. L'acide, de façon générale, peut être associé à des oedèmes des membres inférieurs qui sont en général blancs, mous, indolores, prenant le godet.

Il peut être aussi associé à un hydrothorax qui est souvent du côté droit. Le diagnostic est aisé et facile lorsqu'on a un acide libre de moyenne ou de grande abondance. Par contre, il devient difficile dans les acides minis, dont les acides cloisonnés ont kysté.

Pour cela, on aura besoin de réaliser une échographie abdominale. La ponction, lorsqu'on fait une ponction ramée de liquide, ça permet aussi de confirmer la présence de l'acide. Grâce à l'examen clinique et l'échographie, on peut éliminer tout ce qui n'est pas acide et qui peut donner aussi une matité, notamment un globe visical qui est généralement responsable d'une matité convexe vers le haut.

Le kystovarien qui peut poser un problème de diagnostic différentiel avec les acides cloisonnés, l'échographie Pellebien permet donc de faire le diagnostic. La même chose pour les fibromes utérins, pour l'épice de mesentères, pour une éventuelle hygronephrose ou pour une grossesse. Le diagnostic différencié se fait aisément par la clinique et l'échographie.

Une fois le diagnostic d'une acide posée, il est important de faire une enquête clinique pour rechercher des signes qui peuvent nous orienter vers une théologie. La clinique repose sur l'interrogatoire qui doit préciser les antécédents de patients, rechercher des facteurs de risque pour une hépatopathie chronique pour les glycéroses telles la consommation d'alcool, les facteurs de risque. La fonction d'acide peut être uniquement exploratrice, c'est-à-dire on va prélever le liquide, on va l'étudier.

Il peut parfois peut-être amener, dans certaines situations, de réaliser des fonctions évacuatrices dans des situations bien précises. L'étude des caractères de l'acide est très importante dans l'enquête étiologique. En fait, déjà les caractères macroscopiques sont très importants à rechercher et à préciser.

Est-ce qu'il s'agit d'un liquide joncitrin ? Est-ce qu'il s'agit d'un liquide trouble qui peut nous orienter déjà vers une surinfection ? Est-ce qu'il s'agit d'un liquide hémorragique qui peut nous orienter vers une éventuelle origine myoplasique ? Est-ce qu'il s'agit d'un liquide chûleux qui peut nous orienter vers un problème de compression des canaux lymphatiques, une acide chûleuse ? Est-ce qu'il est gélatine ? Deuxième critère qui est aussi important, c'est l'étude biochimique de liquide. Il est très important de préciser le taux des protéines parce que si on a un taux de protéines qui est inférieur à 25 grammes, on dit que c'est une acide qui est transudatif, pauvre en liquide, et ça oriente vers un certain nombre d'étiologies. Par contre, si le taux des protéines est supérieur à 25 grammes, là c'est un liquide qui est riche en protéines, exudatif, et donc ça oriente sur d'autres étiologies.

Donc, c'est très important de faire cette étude biochimique. Dans cette étude biochimique, le taux de protéines reste le critère le plus important. Bien sûr, on peut être parfois dans certaines situations à doser de la mylase, en particulier lorsqu'on veut faire un diagnostic différentiel entre une origine pancréatique ou autre, on peut être amené à doser le glucose ou le chlore.

Il faut aussi étudier les caractères cytologiques de ce liquide en précisant le taux des polycarnotrophies, des lymphocytes, des globules rouges, des cellules mésothéliales, et de rechercher aussi des cellules néoplasiques. Si on a un acide qui contient plus de 1000 globules rouges par millimètre, on sait que c'est un acide hémorragique et ça doit nous faire craindre une origine tumorale. Si on trouve un taux de PNN supérieur à 250 éléments par millimètre cube, c'est un signe qui permet de retenir une infection du liquide d'acide.

Et ça c'est très important, ce taux de PNN, parce que la surinfection du liquide d'acide reste une complication grave de l'acide et nécessite une prise en charge immédiate. Habituellement, le liquide au niveau du péritoine est stérile et la découverte d'un germe au niveau du liquide d'acide, donc là aussi, ça signe l'infection. Concernant les étiologies, on a d'abord, comme ça a été dit, on distingue entre les acides qui sont riches en protéines et les acides qui sont pauvres en protéines.

Pour les acides qui sont riches en protéines, on évoque en premier un acide de tuberculose parce qu'il reste très fréquent comme étiologie. En particulier chez patients qui ont un état général altéré, qui ont un févricule ou une fièvre surtout la nuit, qui ont des sueurs nocturnes, qui ont des douleurs abdominales. Chez un patient aussi qui a une autre localisation de tuberculose, notamment un épanchement pleural, des adénopathies ou un comptage tuberculose.

Mais le diagnostic, même s'il est évoqué, ne peut pas être retenu que lorsqu'on le confirme. Donc comment confirmer, comment rattacher un liquide d'acide à une tuberculose ? D'abord, le liquide d'acide au corps de la tuberculose, c'est un liquide qui est jancitrin, qui est riche en protéines, notamment il est superavancécrin, qui est à prédominance lymphocytaire. Ça c'est des éléments qui sont en faveur de la tuberculose.

Mais pour dire que ce liquide riche en protéines a prédominance lymphocytaire d'origine tuberculose, il faut isoler le bécane dans le liquide d'acide. Il faut savoir que le liquide d'acide est possiblement, pour cela il faut le centrifuger pour augmenter la chance d'isolement du bécane dans le liquide d'acide. Il faut faire l'acculture de ce liquide dans le milieu spécial d'Aubinstein.

Il faut savoir que même dans une tuberculose péritoniale, lorsqu'on fait l'arrosage du bécane, il peut être négatif. Donc c'est pour ça qu'on complète, s'il est négatif, l'examen direct de l'acculture, on peut faire l'arrosage du bécane par PCR, le gène expert, dans le liquide. Et même s'il est négatif, on ne peut pas écarter la tuberculose.

On fait un dosage de l'activité de l'adénosine des amines, que lorsqu'il est augmenté, il est aussi en faveur de la tuberculose. Et si on n'arrive pas à confirmer, on va faire une biopsie péritoniale, soit par la laparoscopie ou par la laparotomie. La biopsie péritoniale va permettre de retenir, en absence d'isolement du bécane dans le liquide d'acide, de retenir le diagnostic en montrant un granulome épithélial en temps cellulaire avec nécrose cavitaire.

Et parfois, si on ne trouve pas cette nécrose cavitaire, on peut faire une PCR avec recherche de bécane sur ces biopsies qui permettent de retenir le diagnostic. En fait, l'acide d'origine tuberculose, c'est un acide qui est riche en protéines à prédominance lymphocytaire et pour la rattacher à l'origine tuberculose, donc si on a un taux d'adénosine des amines élevé avec d'autres localisations, ça nous permet de retenir le diagnostic. Sinon, il faut isoler soit le bécane dans le liquide d'acide, soit faire une étude histologique, un prélèvement biopsique du péritoine avec une étude histologique.

Le deuxième diagnostic qui est assez fréquent, c'est la carcinose péritoniale. La carcinose péritoniale, c'est un acide qui est aussi riche en protéines, qui peut être jancitrine ou hémorragique, mais généralement, on a le contexte qui est très évocateur, donc la tumeur qui est digestive ou extra-digestive, qui permet de faire retenir le diagnostic. On a aussi, plus rarement, les acides riches en protéines pancréatiques et dans ce cas, ils peuvent être liés soit à une rupture d'un pseudocyste pancréatique dans la cavité péritoniale ou d'un canal pancréatique dans la cavité péritoniale.

Le liquide, là aussi, va être riche en protéines jancitrines. Lorsqu'on va faire le dosage de l'amylase au niveau de l'acide, on va trouver que le rapport amylase acétique sur amylase sérique est supérieur à 1. Le diagnostic, à ce moment-là, de l'origine pancréatique est très suspecté et l'imagerie permet de le confirmer. Il y a aussi les acides par obstacle suscépatiques, par exemple dans l'insuffisance cardiaque droite ou dans l'aperturage cardico-constructif ou lorsqu'on a un obstacle sur la veine cave inférieure ou dans le syndrome de Budd-Chiari qui est une difficulté d'écoulement dans le liquide du sang du foie vers la veine cave inférieure, donc un obstacle sur les veines suscépatiques, donc ils peuvent s'accompagner au début par un acide qui va être riche en protéines et qui est pauvre en sères.

Mais dans tous les cas, l'imagerie permet d'évoquer le diagnostic. Il y a aussi le syndrome de Demenz-Metz qui associe une tumeur ovarienne bénigne ou maligne avec un hydrothorax le plus souvent droit, mais dans cette situation, l'échographie permet de poser le diagnostic. Il y a d'autres causes qui sont plus rares.

On a dans le syndrome d'hypothyroïdes qui s'accompagnent du myxodème, on peut avoir parfois un acide riche en protéines. Il y a aussi l'insuffisance rénale terminale chez les patients dialysés qui peuvent s'accompagner d'un acide riche en protéines. La physiopathologie de cet acide reste mal connue.

Il y a les maladies de système comme le lupus, la péiarthrite, l'oueuse, le perpérinomatôide qui peuvent s'accompagner aussi d'un acide riche en protéines. Les gastroenterites et les eosinophiles qui peuvent intéresser la paroi digestive et prédominer sur la sérose peuvent aussi s'accompagner d'un acide riche en eosinophiles. On a le syndrome de PONS, c'est une cause rare d'acide qui associe en général un gros organe, le plus souvent il s'agit d'une pathomégalie, avec des polyneuropathies et une endocrinopathie avec une atteinte cutanée.

Ils s'accompagnent d'une protéine monoclonale, il faut y penser devant l'association de ces anomalies. Il y a aussi la maladie du wep, qui peut toucher le péritoine, c'est une maladie infectieuse caractérisée par une infiltration du coriandre de l'intestin par des macrophages qui contiennent cette bactérie et qui sont responsables d'une inflammation importante. L'atteinte est généralement multiviscérale et la teinte péritoniale est rare, mais elle est possible.

Généralement, le contexte clinique et les biopsies permettent de poser le diagnostic. Il y a des cas particuliers, comme la maladie gélatineuse de péritoine, où on aura un acide avec une accumulation de mycènes dans la cavité péritoniale. L'acide sera donc gélatineuse, parfois difficile à ramener lors de la ponction d'acide.

On aura besoin d'un trocard de brocaline pour pouvoir ramener cette substance gélatineuse épaisse. Les coces, ce sont des tumeurs qui secrètent de la gélatine, notamment le cystadénome, le cystadénocarcinome, qui peuvent être digestifs ou ovariens. Le deuxième cas particulier, c'est les acides chileuses, qui sont dues à un obstacle lymphatique.

On va les suspecter devant un aspect lactasant du liquide d'acide. Lorsqu'on va faire le dosage des tréglycérides dans ce liquide, on va trouver que le tréglycéride dans l'acide est supérieur au tréglycéride plasmatique. Cela va nous orienter vers l'acide chileuse.

On va donc orienter notre enquête étiologique dans ce sens. L'acide peut être à l'origine de complications mécaniques, notamment dans les acides de grande abondance qui vont entraîner une dyspnée. Ils peuvent aussi entraîner une hernie de la paroi, de la ligne blanche ou de l'embellé.

Ils peuvent être à l'origine d'un étranglement herniaire, d'une éventration sur une ancienne

cicatrice. Parfois, ils peuvent entraîner une rupture de l'onguillite. La deuxième complication aussi de ces acides, c'est la complication infectieuse, la surinfection du liquide.

Cela se voit essentiellement chez les serotides, que c'est une complication qui est grave et qui nécessite parfois une prise en charge en urgence spécifique. Pour conclure, l'acide reste un symptôme clinique, reste un symptôme qui relève des pathologies variables, de pronostics différents. Leur enquête étiologique repose essentiellement sur la clinique, l'échographie et les données de la fonction d'acide qui précise la nature du liquide d'acide.

Je vous remercie.